

ESCORE QSOFA (QUICK SOFA)

Triage Rápida à Beira do Leito para Risco de Deterioração Clínica em Pacientes com Infecção

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome:		Idade:	
Prontuário:		Leito:	
Setor:		Data/Hora:	___/___/___ às __:__

2. CRITÉRIOS CLÍNICOS DE TRIAGEM RÁPIDA DE SEPSE (MARCAR SE PRESENTE)

Critério Clínico	Definição Operacional e Método de Verificação	Ponto de Corte	Pontos
1. Frequência Respiratória Taquipneia aguda	Contagem de incursões respiratórias completas por 60 segundos com o tórax do paciente em repouso.	FR $\geq$ 22 rpm	[] 1 ponto
2. Estado Mental Alteração aguda do sensorio	Qualquer rebaixamento ou alteração do estado cognitivo prévio basal (Glasgow $<$ 15).	Glasgow $<$ 15	[] 1 ponto
3. Pressão Arterial Hipotensão sistólica	Aferição pressórica por método auscultatório com manguito calibrado ou PAI.	PAS $\leq$ 100 mmHg	[] 1 ponto

PACOTE DE RESPOSTA IMEDIATA NA SUSPEITA DE SEPSE (1ª HORA)

- ☐ Coleta imediata de lactato arterial/venoso e reavaliação seriada se $\geq$ 2 mmol/L.
- ☐ Coleta de pelo menos 2 pares de hemoculturas de sítios distintos antes de iniciar antimicrobianos.
- ☐ Administração precoce de antibióticos de amplo espectro prescritos na primeira hora.
- ☐ Expansão volêmica rápida (30 mL/kg cristalóide) se hipotensão (PAM $<$ 65 ou PAS $\leq$ 100) ou lactato $\geq$ 4.

ESCORE QSOFA TOTAL (0 a 3 PONTOS): []

3. INTERPRETAÇÃO DO ESCORE E CONDUTA IMEDIATA

0 a 1 PONTO (NEGATIVO)

Baixo Risco Imediato pelo qSOFA: Manter vigilância clínica e reavaliação de sinais vitais a cada 4 horas. $\geq$ 2 PONTOS (POSITIVO)**Alto Risco de Sepses Grave:** Acionar imediatamente o Código de Sepses institucional e o Time de Resposta Rápida (TRR).

Carimbo e Assinatura do Profissional Responsável

Local e Data